

## Choque hipovolêmico · classes ATLS

Classifique a hemorragia pela resposta fisiológica. Hipotensão é achado tardio — taquicardia, pele fria e ansiedade já denunciam perda importante.

### Classes ATLS (resumo)

**Classe | % volemia | Sinais-chave**

I | < 15% | Mínimos; PA e FC estáveis

II | 15–30% | Taquicardia, ansiedade; PA normal

III | 30–40% | Hipotensão, oligúria, confusão

IV | > 40% | Choque profundo, letargia

### Conduta-chave

- Controle da hemorragia (compressão, torniquete, pelve, cirurgia)
- Acessos calibrosos / IO; evitar hipotermia e coagulopatia (tríade letal)
- Em trauma penetrante/hemorragico: reposição balanceada com hemoderivados (1:1:1) quando indicado
- Permissive hypotension selecionada até controle da fonte (exceto TCE — manter PPC)

### Resposta ao volume

**Lembre - Resposta ao volume**

Respondedor rápido, transitório ou não-respondedor guia a necessidade de cirurgia/angioembolização.

*Triagem resumida: classe I–II ainda compensada; classe III–IV = choque manifesto e reposição agressiva.*

### Classes de hemorragia

Verde / amarelo / vermelho (visão de prova)

#### Classe I-II

Perda até ~15-30%  
PA normal / limiar  
FC normal ou elevada

**Cristaloide +/- sangue**

#### Classe III

Perda ~30-40%  
Hipotensão  
Oligúria / confusão

**Sangue + controle fonte**

#### Classe IV

Perda > 40%  
Colapso  
Letargia

**Reanimação / sala**

### Armadilha de prova

**Atenção - Armadilha de prova**

Criança e idoso 'compensam' diferente: na criança a hipotensão é muito tardia; no "loqueado" a taquicardia pode estar ausente.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1